



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**FEASIBILITY STUDY SET PCNL
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN
PELAYANAN)
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

FEASIBILITY STUDY SET PCNL
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Penyakit batu saluran kemih merupakan salah satu kasus urologi yang sering ditemukan dan memerlukan penanganan yang efektif untuk mencegah komplikasi seperti infeksi saluran kemih, hidronefrosis, penurunan fungsi ginjal, hingga gagal ginjal. Salah satu metode standar untuk penanganan batu ginjal berukuran besar adalah Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL).

Saat ini pelayanan tindakan PCNL di rumah sakit belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan alat khusus PCNL Set. Akibatnya pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap sehingga berdampak pada keterlambatan pelayanan, peningkatan biaya, serta hilangnya potensi pendapatan rumah sakit.

Berdasarkan standar pelayanan urologi rumah sakit, PCNL Set merupakan salah satu alat yang direkomendasikan untuk mendukung pelayanan bedah urologi modern.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu pelayanan urologi.
- b. Mengurangi angka rujukan pasien batu ginjal ke rumah sakit lain.
- c. Meningkatkan keselamatan pasien melalui tindakan minimal invasif.
- d. Meningkatkan pendapatan rumah sakit dari pelayanan bedah urologi.
- e. Mendukung pengembangan layanan unggulan urologi.

3. Manfaat

- a. Manfaat Klinis

1) Tindakan minimal invasif dengan angka keberhasilan tinggi.

2) Lama rawat lebih singkat.

3) Mengurangi nyeri pasca operasi.

4) Mempercepat pemulihan pasien.
- b. Manfaat Operasional

1) Menambah jenis layanan spesialisik.

2) Mengurangi rujukan keluar.

3) Meningkatkan citra rumah sakit.
- c. Manfaat Finansial

1) Meningkatkan pendapatan pelayanan bedah urologi.

2) Meningkatkan utilisasi kamar operasi.

3) Meningkatkan pendapatan rawat inap dan penunjang medis.

4. Data Pasien

Tabel 1. Jumlah pasien yang dirujuk Pro PCNL Tahun 2025 – Juni 2026

No	Diagnosa	Tindakan	Jumlah Pasien		Tarif InaCBGS		
			2025	2026	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
1.	Batu Renal + Hydoneprosis	Pro PCNL	21	19	11.200.000	9.810.500	8.421.100
2.	Batu Staghorn	Pro PCNL	14	15	11.200.000	9.810.500	8.421.100
3.	Batu Pyelum + Hydroneprosis	Pro PCNL	2	11	11.200.000	9.810.500	8.421.100

5. Jumlah SDM

Tabel 2. Jumlah SDM spesialis Urologi di RS Prima Husada Sukorejo

No	Jenis Sdm	Jumlah
1	Dokter Spesialis Urologi	2

6. Analisis Situasi

- a. Analisis Situasi Internal
- 1) Kekuatan

a) RS Prima Husada Sukorejo adalah satu-satunya RS Tipe C di Kab. Pasuruan

b) RS Prima Husada Sukorejo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya

c) RS Prima Husada Sukorejo telah memiliki dokter spesialis urologi yang kompeten dalam melakukan tindakan PCNL

d) Komitmen manajemen rumah sakit dalam meningkatkan layanan Urologi

e) Meningkatnya jumlah pasien Urologi dengan diganosa yang membutuhkan tindakan PCNL

f) Ruang operasi yang tersdandart dengan C-Arm

g) Tersedia tim bedah dan anestesi
- 2) Kelemahan

a) RS Prima Husada Sukorejo belum memiliki PCNL Set sehingga pelayanan PCNL belum dapat dilakukan secara mandiri dan optimal.

b) Pasien yang memerlukan tindakan PCNL masih dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

c) Tindakan spesialis Urologi yang tidak muncul setiap hari
- b. Analisis Situasi Eksternal
- 1) Peluang

a) Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat

b) Meningkatnya jumlah kasus pasien dengan pro PCNL meningkat di tahun 2026

c) Tindakan PCNL termasuk dalam paket INA – CBGs
- 2) Ancaman

a) Persaingan dengan rumah sakit yang lebih dulu melakukan pelayanan

7. Rencana Pengajuan Unit

Jenis : Set Instrumen PCNL

Jumlah : 1 set

Table 3 Spesifikasi Instrumen Set

ENDO

LIST ITEM PCNL

No	Art No	Description	Qty	UNIT
	PCNL			
1	TONO/601-122-45	nephroscope 15* 1 working channel Ø5mm;2 fixed stopcocks 26Fr; 200mm TONO/601-122-45	1	Pc
2	601-120-12	instrument bridge for nephroscope 601-120-12	1	Pc
3	630-420-26	nephroscopy sheath without obturator 1 turnable stopcock; distal drainage 26 Fr; 175mm 630-420-26	1	Pc
4	630-420-24	Operating Sheath, 26 Fr.; nephroscopy sheath; 1 turnable stopcock; 26 Fr; 175mm 630-420-24	1	Pc
5	630-420-27	obturator for nephroscope 26 Fr. 630-420-27	1	Pc
6	630-470-35	Grasping forceps for large stones and stone fragments, 3 expanding jaws 630-470-35	1	Pc
7	630-451-35	Grasping forceps for large stones and stone fragments with fenestrated jaws 630-451-35	1	Pc
8	630-452-35	Grasping forceps for laarge stones and stone fragments, serrated, double jaw action 630-452-35	1	Pc
9	630-430-00	dilatation set for nephroscope Content: 1 guide wire rigid + flexible 1 each dilator Ø9,12,15,18,21,24Fr 630-430-00	1	Pc
10	630-430-27	Dilator 27 Fr 630-430-27	1	Pc
11	630-430-30	Dilator 30Fr 630-430-30	1	Pc

ENDO

LIST ITEM MINI PCNL

NO	ART NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT
	MINI PCNL			
1	601-145-00	Nephroscope; 45 degree angled; working channel (diameter) 2.2 mm 601-145-00	1	Pc
2	630-435-15	Nephroscopy sheath; 15/18 Fr 630-435-15	1	Pc
3	630-435-35	Dilatator for guide wire; for 15/18 Fr; sheath; length 300mm 630-435-35	1	Pc
4	630-435-40	Dilatator; 2 channel for introduction of guide wire; for 16.5/ 19.5 Fr sheath; length 300mm 630-435-40	1	Pc
5	630-455-18	PE Forceps cup; sharp; single action; dia 1.8mm; FL 400mm; with irrigation adapter 630-455-18	1	Pc
6	630-471-18	3 Prongs retriever; semi-rigid; dia 1.8mm; FL 400mm; with firmly welded spring grip 630-471-18	1	Pc

8. Penutup

Berdasarkan analisis kebutuhan, manfaat klinis, operasional, dan finansial, pengadaan PCNL Set dinilai layak untuk direalisasikan. Pengadaan alat ini akan meningkatkan mutu pelayanan urologi, mengurangi rujukan pasien keluar rumah sakit, meningkatkan kepuasan pasien, serta mendukung pengembangan layanan unggulan rumah sakit.

	Pasuruan, 30 Juni 2026
Menyetujui, Direktur RS Prima Husada	Diajukan Oleh, Kepala Bidang Pelayanan
 KUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	
Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep	Ns. Sisca Puspitasari, S. Kep

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTEK KLINIS (PPK) TINDAKAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2026
PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY (PCNL)	
Pengertian (Definisi)	Percutaneous Nephrolithotomy merupakan tindakan operasi endourology untuk menghancurkan dan mengambil batu Ginjal melalui akses perkutan.
Tujuan	1. Menghilangkan batu ginjal secara efektif melalui akses perkutan dengan meminimalkan komplikasi 2. Mempertahankan fungsi ginjal 3. Mengatasi obstruksi dan / atau infeksi terkait batu 4. Mencapai kondisi stone-free atau residual stone minimal
Indikasi	1. Batu pyelum 2. Batu staghorn 3. Batu ginjal (kaliks superior, media, dan inferior)
Kontraindikasi	1. Terdapat kontra indikasi pembiusan 2. Didapatkan tumor di area puncture 3. Gangguan faal hemotasis 4. Sepsis
Persiapan Tindakan	1. Persiapan personalia a. Operator dokter Urologi b. 1 dokter anastesi c. 1 asisten anastesi d. 1 perawat asisten operator e. 1 perawat instrumen f. 1 perawat sirkuler g. 1 radiografer 2. Persiapan pasien a. Anamnesis dan edukasi b. Informed consent terdokumentasi c. Menentukan lokasi, ukuran, jumlah, dan kompleksitas batu. d. Menilai kondisi ginjal dan adanya obstruksi/hidronefrosis. e. Menilai adanya infeksi saluran kemih. f. Puasa 6 jam 3. Persiapan operasi a. Konsultasi dokter anastesi 1) Puasa 6 jam 2) Cairan infus RL 20 tpm 3) Premedikasi : Injeksi Ranitidin dan Metoclorpamid b. Konsultasi dokter bedah 1) Anamnesis dan Edukasi : Menjelaskan prosedur, risiko (perdarahan, infeksi, alergi, jaringan parut), dan meminta persetujuan (informed consent). 2) Pemeriksaan : Mencatat riwayat alergi, gangguan perdarahan, atau riwayat lainnya 3) Pemberian premedikasi : Injeksi antibiotik Cefazolin c. Pemeriksaan laboratorium ➤ DL ➤ Gol. Darah ➤ PTT ➤ KPTT ➤ GDA ➤ EKG (usia lebih dari 40 tahun) ➤ UL ➤ SE ➤ Ureum ➤ Creatinin d. Pemeriksaan penunjang lain ➤ Thorax / Ro lainnya

	➤ USG ➤ BOF ➤ CT Scan Abdomen Tanpa Kontras e. Persiapan alat operasi f. <i>Informed consent</i> dari pasien atau keluarga
Pelaksanaan Tindakan	1. Pengecekan identifikasi pasien 2. Pasang foto radiologi di film viewer 3. Pasien diposisikan Bart Flank Free modified supine dengan general anastesi 4. Pembacaan SSC (Surgical Safety Checklist) 5. Melakukan cystoscopy sesuai dengan SOP 6. Memasukkan kateter ureter sesuai ukuran ke orifisium ureter, 7. Melakukan retrograde pyelografi melalui kateter ureter untuk melihat anatomi dari ureter hingga collecting system 8. Ureter kateter dimasukkan hingga pelvis renalis (bila tidak didapatkan obtruksi di distal pelvis renalis), bila didapatkan obstruksi di ureter dilakukan prosedur URS 9. Pasang kateter uretra 16 Fr, fiksasi ureter kateter pada kateter uretra dan sambungkan dengan spuilit 50cc yang berisi kontras 10. Masukkan jarum PNL 21 G di bawah costae 12 dengan sasaran kaliks posterior dari pole bawah dengan arahan dari C-arm (dinyatakan masuk bila keluar urine) . 11. Guidewire dimasukkan melalui lubang jarum sampai pelvis renalis. 12. Masukkan dilators melalui guidewire ke dalam sistem kalises. sampai sekitar 26-30 F. 13. Masukkan Amplatz sheath melalui dilator 14. Masukkan 26 Fr nephroscope ke dalam ginjal melalui Amplatz sheath hingga ke lokasi batu. 15. Ambil batu ukuran kecil dengan forseps atau pecah batu besar menjadi fragmen-fragmen kecil dengan lithotripsy (pneumatic, ultrasound atau laser), 16. Keluarkan nephroscope dan guide wire, masukkan kateter percutaneous nephrostomy 20 Fr, masukkan kontras untuk memastikan posisi kateter, 17. Keluarkan amplatz sheath, fiksasi kateter. 18. Buat laporan pelaksanaan prosedur tindakan.
Perawatan Pasca Tindakan	1. Diberikan cairan infus RL atau NaCL 20 tpm dan injeksi Santagesik 3x1 gr selama 24 jam pertama pasca tindakan 2. Monitoring kondisi umum 3. Monitoring vital sign 4. Monitoring Urine 5. Perawatan Nephrostomy Tube 6. Manajemen nyeri 7. Pencegahan dan deteksi infeksi 8. Pemeriksaan laboratorium 9. Mobilisasi 10. Nutrisi dan cairan 11. Evaluasi hasil tindakan
Tingkat Evidens	III
Tingkat Rekomendasi	C
Penelaah Kritis	1. dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp. U 2. dr. Muhammad Adi Satrio, Sp. U
Kepustakaan	1. Campbell's Urology, 9th ed., Section 3, Chapter 6, Tahun 2007 2. Smith's General Urology, Edisi 17, Tahun 2008, hal. 155 – 156 3. Dasar-dasar Urologi, Edisi kedua, Tahun 2007, hal. 227 – 229

Clinical Pathway : Prosedur Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)



Etiket Pasien

Keterangan :

: yang harus dilakukan : Bisa ada atau tidak Beri tanda (√) : Bila sudah dilakukan

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Hari Ke -							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1. PENGKAJIAN AWAL									
a. Pengkajian Awal	Dokter IGD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pasien masuk via IGD
	Dokter Spesialis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pasien masuk via RJ
b. Pengkajian awal keperawatan	Perawat primer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. LABORATORIUM									
	DI (darah lengkap)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Gol. Darah	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	PTT / KPTT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	GDA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Ureum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Creatinin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	SE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	UL (urine lengkap)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sesuai indikasi
	EKG	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sesuai indikasi
3. RADIOLOGI IMAGING /	USG	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	BNO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Thorax	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sesuai indikasi
	CT Scan Abdomen tanpa kontras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. KONSULTASI	Dokter spesialis Urologi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Dokter spesialis anastesi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. PENGKAJIAN LANJUTAN									
a. Pengkajian medis	Dokter DPJP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Visite harian / follow up
	Konsul dokter jaga	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Atas indikasi / emergency
b. Pengkajian keperawatan	Perawat penanggung jawab asuhan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dilakukan 3 shift
c. Pengkajian gizi	Tenaga gizi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lihat risiko mal nutrisi melalui skrining gizi dan mengkaji data antropometri, biokimia, fisik / klinis, riwayat makan termasuk

								alergi makanan serta riwayat personal. Pengkajian dalam waktu 48 jam
g. Pengkajian farmasi	Telaah resep							Dilanjutkan dengan intervensi farmasi yang sesuai hasil telaah dan rekonsiliasi obat
	Rekonsiliasi obat							
6. DIAGNOSIS								
a. Diagnosa medis	1. Batu Ginjal (Kaliks Superior, Media, Inferior), atau 2. Batu Pyelum, atau 3. Batu Staghorn							
b. Diagnosa keperawatan	Nyeri akut							Masalah keperawatan yang dijumpai setiap hari. Dibuat oleh perawat penanggung jawab pasien
	Risiko perdarahan							
	Risiko infeksi							
	Gangguan eliminasi urine							
	Risiko disfungsi eliminasi urin							
	Risiko hipovolumia							
	Gangguan mobilitas fisik							
	Risiko jatuh							
	Anxietas							
	Defisit pengetahuan							
c. Diagnosa gizi								Sesuai dengan data pengkajian, kemungkinan saja ada diagnosis lain atau berubah selama perawatan
7. DISCHARGE PLANNING								
	Informasi tentang aktivitas yang dapat dilakukan sesuai dengan tingkat kondisi pasien							Program pendidikan keluarga
	Terapi yang diberikan meliputi							

	kegunaan obat, dosis dan efek samping								
	Menjelaskan gejala kekambuhan penyakit dan hal yang dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul								
	Diet yang dapat dikonsumsi selama pemulihan kondisi yaitu diet lunak yang tidak merangsang dan tinggi energi serta protein								
	Anjurkan untuk istirahat								
8. EDUKASI TERINTEGRASI									
a. Edukasi / informasi medis	Penjelasan tindakan								Oleh semua pemberi asuhan berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan Discharge Planning
	Rencana terapi dan tindakan								
	Informed consent								
b. Edukasi dan konseling gizi	Diet pra bedah dan pasca bedah, makan lunak, saring lunak / makan biasa TKTP setelah operasi bertahap								Edukasi gizi dilakukan saat diawal masuk dan atau pada hari ke 1 atau hari ke 2
c. Edukasi keperawatan	Edukasi sebelum tindakan								Pengisian formulir informasi dan edukasi terintegrasi oleh pasien dan atau keluarga
	Edukasi setelah tindakan								
	Edukasi tanda bahaya								
	Edukasi pencegahan kekambuhan batu								
	Edukasi saat pulang								
d. Edukasi farmasi	Informasi obat								Meningkatkan kepatuhan pasien meminum / menggunakan obat
	Konseling obat								

[illegible]

	manak biasa Tinggi Kalori dan Tinggi Protein (TKTP) selama pemulihan								kebutuhan zat gizi disesuaikan dengan usia dan kondisi klinis secara bertahap
d. TLI Farmasi	Rekomendasi kepada DPJP								Sesuai dengan hasil monitoring
11. MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN PASIEN									
a. Dokter DPJP	Pengkajian ulang dan review verifikasi rencana asuhan								Monitoring perkembangan pasien
b. Keperawatan	Kesadaran								
	Tanda – tanda vital								
	Neyri								
	Perdarahan								
	Elimisai urine								
	Nephrostomy tube								
	Kateter urine								
	Luka operasi								
	Tanda infeksi								
	Balance cairan								
	Fungsi ginjal								
	Mobilisasi								
	Risiko jatuh								
	Nutrisi dan hidrasi								
	Psikologis								
	Pengetahuan								
	Komplikasi								
c. Gizi	Monitoring asupan makanan								Sesuai dengan masalah gizi dan tanda gejala yang akan dilihat kemajuannya
	Monitoring antropometri								
	Monitoring biokimia								
	Monitoring fisik / klinis terkait gizi								
d. Farmasi	Monitoring interaksi obat								Dilanjutkan dengan intervensi farmasi yang sesuai
	Monitoring efek samping obat								
	Pemantauan terapi obat								
12. MOBILISASI / REHABILITASI									
a. Medis	Mobilisasi bertahap								
b. Keperawatan	Dibantu sebagian / mandiri								Tahapan mobilisasi sesuai kondisi pasien
c. Fisioterapi									
13. OUTCOME / HASIL									
a. Medis	Evakuasi batu berhasil dengan								

	kondisi hemodinamik stabil									
	Obstruksi teratasi	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Fungsi ginjal terjaga	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Tidak terjadi komplikasi mayor	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Infeksi / sepsi maupun perdarahan bermakna	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Pasien memenuhi kriteria pulang dan memiliki rencana tindak lanjut	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
b. Keperawatan	Nyeri terkontrol	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
	Eliminasi urine adekuat	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
	Tidak terjadi perdarahan dan infeksi	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
	Keseimbangan cairan terpantau	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Mobilisasi aman	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
	Alat invasif dirawat bila dipasang	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
	Pasien dan keluarga mampu memahami perawatan pasca PCNL	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
	Tanda bahaya	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
c. Gizi	Asumsi makanan ≥ 80%	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
d. Farmasi	Terapi obat sesuai indikasi	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Obat rasional	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
14. KRITERIA PULANG	Kondisi umum stabil dan tidak terdapat kegawatn.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Tanda vital stabil sesuai kondisi klinis pasien.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Kesadaran baik dan telah pulih dari efek anestesi.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Nyeri terkontrol dengan analgesik oral atau terapi yang dapat dilanjutkan di rumah.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Tidak terdapat perdarahan bermakna atau hematuria berat yang memerlukan intervensi.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
	Produksi urine adekuat dan tidak terdapat tanda obstruksi/retensi urine.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		

	Tidak terdapat demam atau tanda infeksi/sepsis.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Fungsi ginjal stabil atau sesuai kondisi baseline.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Tidak terdapat komplikasi mayor yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Nephrostomy tube/DJ stent bila masih terpasang dalam kondisi baik dan pasien/keluarga telah mendapatkan instruksi perawatannya.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Pasien mampu makan dan minum sesuai toleransi.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Pasien mampu mobilisasi sesuai kondisi atau telah tersedia bantuan untuk mobilisasi di rumah.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Hasil evaluasi dokter urologi menyatakan pasien layak pulang.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Rencana kontrol dan tindak lanjut telah ditentukan.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
15. RENCANA PULANG / EDUKASI PELAYANAN LANJUTAN 2)	Cara minum obat sesuai resep.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Perawatan luka operasi.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Perawatan nephrostomy tube bila masih terpasang.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Perawatan kateter bila masih terpasang.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Aktivitas yang diperbolehkan dan yang perlu dihindari.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Asupan cairan sesuai anjuran dokter.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Pola makan sesuai jenis batu dan rekomendasi dokter/gizi.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Pentingnya tidak menahan buang air kecil.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Jadwal kontrol ke Dokter Spesialis Urologi.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	

	Rencana pemeriksaan imaging atau evaluasi lanjutan bila diperlukan.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	Pencegahan kekambuhan batu.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	

Pasuruan, 1 Juli 2026

Ketua Komite Medik



dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp. PD

Ketua SMF Urologi



dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep